

ONE-TIME GENE THERAPY

一次给药,改写 **SMA** 的一生

把不可逆的运动神经元退变,拦在发生之前。

CONTENTS · 目录

本次汇报

01 疾病负担

02 诊疗路径

03 关键指标

04 现存问题

05 改进方案

06 资源需求

01

疾病负担

脊髓性肌萎缩 SMA的流行病学与临床现状

早识别、早干预， 是改变脊髓性肌萎缩 **SMA**结局的 关键

时间窗决定神经功能的可挽救程度

诊疗路径 · PATHWAY

脊髓性肌萎缩 SMA 的四步管理

早期识别

基于典型症状与量表快速筛查

确诊分型

影像 + 电生理 + 抗体检测

规范治疗

急性期干预与长期维持并重

康复随访

功能评估与并发症防控

* 路径依据最新专家共识

发病机制与干预靶点

病理基础

- 神经元/髓鞘损伤
- 炎症与免疫异常
- 神经环路受累

关键指标(示例)

onset : 急性/亚急性
target : 免疫调节
window : 4.5h
score : mRS 0-2

三大支柱

综合管理的三个维度

急性期

快速稳定,把握可逆的治疗时间窗

维持期

预防复发,控制疾病活动度

康复期

功能重建与生活质量提升

对比 · BEFORE / AFTER

规范化管理前后

干预前

分散诊疗

- 识别延迟
- 路径不统一
- 随访脱节

干预后

闭环管理

- 快速通道
- 标准路径
- 全程随访

典型影像表现

脊髓性肌萎缩 SMA在 MRI/CT 上有其特征性征象,是确诊与分型的重要依据。规范化的影像采集与判读流程,能显著提升诊断一致性。

“影像必须结合临床与实验室,单一征象不足以定论。”

— 诊断规范

此处放置影像图

关键指标 · KPI

本年度诊疗数据

年接诊量

1,240 例

↑ 18%

确诊时间

3.2 天

↓ 0.8 天

规范治疗率

91 %

↑ 6 pt

年复发率

12 %

↓ 3 pt

关键数据 · RESULT

1次

静脉输注,终身一次

针对 SMN1 双等位基因缺失患者的一次性基因替代治疗。

路线 · ROADMAP

三年建设时间线



明细 · DATA

分型与治疗方案

分型	占比	一线方案	预后
经典型	62%	标准治疗	良好
进展型	24%	强化方案	中等
难治型	14%	个体化	需随访

来源： 科室登记数据 2026

流程 · PROCESS

急救绿色通道

识别

症状快速筛查



分诊

开通绿色通道



干预

时间窗内处置



转归

收治与随访

让每一位脊髓性肌萎缩患者都 得到规范诊疗

基因治疗新品发布

推进标准化路径落地